

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, **resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.**

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a agravante **não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida**, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do procedimento de criopreservação de óvulos indicado a paciente oncológica, diante da alegada ausência de cobertura no rol da ANS e da discussão acerca de sua natureza taxativa mitigada.

Pois bem, compulsando os autos, entendo estar demonstrada que a agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (ID 148553242 – PJE 1º GRAU – Processo nº 0867402-97.2025.8.14.0301), bem como está demonstrada a solicitação ao plano de saúde (ID 148550699 - PJE 1º GRAU – Processo nº 0867402-97.2025.8.14.0301).

Com efeito, observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de

procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Em que pese o argumento da Recorrente de que o procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, nem no contrato firmado entre as partes, tem-se que a jurisprudência pátria (inclusive do Superior Tribunal de Justiça) vem assentando que o referido rol, conquanto mantenha natureza taxativa, admite exceções quando presentes critérios específicos, mormente quando há comprovação da necessidade médica do procedimento e sua eficácia terapêutica.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados pelo médico.

O procedimento de criopreservação de óvulos prescrito com o fim de prevenir a infertilidade em pacientes submetidas à quimioterapia não se confunde com técnica de reprodução assistida, cuja cobertura contratual pode ser afastada. Trata-se, na verdade, de procedimento terapêutico voltado à preservação da função reprodutiva como medida de mitigação dos efeitos adversos previsíveis do tratamento da doença coberta (câncer), à luz do disposto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”.

Em reforço, é de se registrar o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no qual se reconheceu que, em casos de mulheres férteis, submetidas a tratamento oncológico com risco de falência ovariana, a cobertura da criopreservação de óvulos configura-se como obrigação contratual derivada da obrigação maior de preservar a saúde, nos moldes do art. 35-F da Lei 9.656/1998. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA . RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 387/2016. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA NOS TERMOS DO VOTO DA MIN .a NANCY ANDRIGHI. 1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 2 . Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artificial", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida (cf. RN ANS 387/2016) . 3. Descabimento, portanto, de condenação da operadora a custear criopreservação como

procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida. 4. Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non nocere" e à norma que emana do art. 35-F da 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. 5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico, nos termos do voto da Min.ª NANCY ANDRIGHI. 6. Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueles em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1815796 RJ 2019/0150440-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 introduziu o §13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, prevendo expressamente que procedimentos fora do rol da ANS podem ser autorizados quando preenchidos determinados requisitos:

“§13. É obrigatória a cobertura de tratamento ou procedimento, ainda que não incluído no rol de que trata o §4º deste artigo, quando:

I – houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

II – existirem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ou, no mínimo, por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais.”

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

No caso sob exame, restou evidenciada a prescrição médica do procedimento, que visa preservar a fertilidade da paciente, jovem e ainda em idade fértil, e mitigar os efeitos deletérios previsíveis da quimioterapia. A negativa de cobertura, portanto, além de implicar violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, configura conduta abusiva nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado aos contratos de plano de saúde conforme a Súmula nº 608 do STJ.

Desta forma, a presunção é que há sim falha na prestação do serviço e que deve ser mantida a

tutela até o pronunciamento de mérito sobre o tema.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco à saúde do menor, considero presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e escorreita a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso de **AGRAVO INTERNO**, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora